

Projekt Pitch: Pre-Check-In-Erweiterung für Docotlib

Wir planen die Entwicklung einer Applikation, die als funktionale Erweiterung bestehender Buchungssysteme (analog zu Doctolib) fungiert: Ein **digitales Pre-Check-in-System**.

Kernproblem & Lösungsansatz: Der klassische Praxisbesuch ist oft geprägt von manuellem Papierkram und unvorhersehbaren Wartezeiten. Unser System setzt bereits vor dem Betreten der Praxis an, um den administrativen Aufwand zu digitalisieren und die Behandlungsqualität durch strukturierte Datenvorbereitung zu erhöhen.

Hauptfunktionen der Applikation:

1. Digitale Anamnese

- **Dynamische Abfrage:** Patienten durchlaufen eine adaptive Befragung (Beschwerden, Medikamente, Allergien). Ein LLM-basiertes Modul stellt kontextbezogene Folgefragen (z. B. spezifische Fragen bei akuten Schmerzen).
- **Dokumenten-Management:** Upload-Funktion für Befunde, Arztbriefe oder Fotos (z. B. bei dermatologischen Anliegen).

2. Geschätzte Wartezeit (Add-on):

- **Status-Tracking:** Nach Abschluss des Pre-Check-ins erhält der Patient eine Schätzung der Wartezeit.
- **Push-Logik:** Benachrichtigung der Patienten, sobald sie sich physisch zur Praxis begeben sollen, um volle Wartezimmer zu vermeiden.

3. Bericht- und Benachrichtigungssystem:

- **Effizienz-Analyse:** Vorbereitung des Arzt-Patienten-Gesprächs durch eine kompakte Übersicht aller vorab übermittelten Daten

Assistierte Vorbereitungsempfehlung: System erstellt auf Basis der Pre-Check-in-Daten Empfehlungen für erste Maßnahmen, die vom Praxisteam geprüft und freigegeben werden, bevor der Patient informiert wird (z. B. „Bitte nüchtern erscheinen“).

Weiterführende Fragen:

Handelt es sich bei dem Projekt um eine Lösung für einen Praxispartner?

Nein, die Projektidee wurde unabhängig von einem konkreten Praxispartner entwickelt.

Ist der Plan eine Mobile App zu entwickeln oder eine Web-Seite? Oder beides?

Geplant ist die Entwicklung einer Website, die über ein Add-In in Doctolib zugänglich ist.

Welche Stakeholder gibt es und welche Features plant Ihr für diese?

Zu den Stakeholdern zählen Ärzt:innen, Sprechstundenhilfen (MFA) und Patient:innen; Patient:innen führen einen digitalen Pre-Check-in durch, dessen Angaben vom System zusammengefasst, von ihnen durch eine digitale Unterschrift bestätigt und anschließend zur Sichtung an das Praxisteam weitergeleitet werden.

Was ist mit den behandelnden Ärzt:innen und Sprechstundenmitarbeiter:innen?

Das Praxisteam sichtet die Berichte, erhält Vorbereitungsempfehlungen durch die KI (z. B. Hinweise zur Nüchternheit), bestätigt oder ergänzt diese und übermittelt sie an die Patient:innen sowie integriert relevante Dokumente in das interne Praxisverwaltungssystem (PVS).

Stehen historische Daten von Patienten zur Verfügung bzw. können diese für die LLM-Komponente benutzt werden?

Zukünftig ist die Nutzung historischer Daten über die elektronische Patientenakte geplant, sofern eine rechtlich zulässige, dauerhafte Einwilligung vorliegt; aktuell ist der Zugriff meist auf etwa 90 Tage begrenzt, perspektivisch soll die KI dadurch kontextbezogener und präziser arbeiten.